G2 — Tuméfaction, tumeur, adénopathie · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v2

LOT_002 audité · Phase A + Phase B (DX.1–15) · 63 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 42 EX · 11 AP · 10 SPE

🧭 Carte mentale G2 · 60 secondes avant de répondre

EX Examen — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP Approfondissement — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité Spécialiste — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant tout ganglion ou toute masse

1. **Danger maintenant ?** Dyspnée, stridor, œdème du visage → **compression médiastinale** ; enfant fébrile ≥ 5 j → **Kawasaki** ; blastes → hématologue aujourd'hui.
2. **Quel ganglion ?** Siège · taille (> 1 cm ; aine jusqu'à 1,5 cm) · consistance · mobilité · douleur · peau. **Localisé ou ≥ 2 régions ?**
3. **Quelle exposition, quel examen qui tranche ?** Porte d'entrée, chat, viande, rapports, voyage/contage, médicaments → une hypothèse = un examen.

📍 Siège

- **Sus-claviculaire** → malin jusqu'à preuve du contraire (≈ 50 %) ; gauche = Virchow → abdomen
- Cervical postérieur + angine + rate → mononucléose
- Cervical antérieur sensible + angine sans toux → streptocoque (Centor)
- Régional sur le trajet d'une griffure → griffes du chat
- Épitrochléen > 0,5 cm → syphilis, lymphome, main
- ≥ 2 régions → VIH, syphilis, EBV, CMV, ANA, hémogramme (RR cancer 6,41)

✋ Caractères

- Sensible, élastique, mobile, chaud → réaction (distension capsulaire)
- Dur, fixe, indolore, conglomérat, rond sans hile → infiltration tumorale
- Froid, fistulisé → tuberculose
- Fluctuant → abcès (drainer) ; griffes du chat (aspirer, ne pas inciser)

⏱️ Temps

- Tableau bénin localisé → revoir à 3–4 semaines
- Persistance > 4–6 semaines, croissance, durcissement → échographie puis **biopsie-exérèse**
- Fièvre ≥ 5 j chez l'enfant → Kawasaki ; traiter avant J10
- 2–8 semaines après un médicament → DRESS / pseudolymphome

🧪 Ce qui tranche

- Lymphome, métastase → **histologie du ganglion entier** (cytoponction ≈ 84 %)
- Tuberculose → PCR + culture du ganglion (l'IGRA ne tranche pas)
- VIH → test combiné 4e génération + ARN (fenêtre)
- Syphilis → tréponémique + non tréponémique
- Mononucléose → hétérophile (faux négatifs 1re semaine, < 5 ans) / VCA-IgM, EBNA
- Toxoplasmose, CMV → avidité des IgG

🚩 Ordre d'exclusion

0. 0 · **Compression médiastinale** — ABC, imagerie, hématologie
1. E1 Kawasaki (DX.15)
2. E2 Néoplasie : lymphome, leucémie, métastase (DX.2)
3. E3 Sus-claviculaire (DX.11)
4. E4 Tuberculose ganglionnaire (DX.12)
5. E5 Primo-infection VIH (DX.13)
6. E6 Syphilis secondaire (DX.14)
7. Puis : médicament, streptocoque, EBV/CMV, chat, granulome/auto-immun, réactionnel

Jamais de corticoïde avant d'avoir exclu un lymphome.

① Raisonner · 11 Q · avant de nommer le diagnostic

Décrire, classer, chercher le danger : quel geste maintenant, avant de nommer la cause ?

Q1 **EX** **DX.11 🚩E3 vs DX.1** Prise en charge · cabinet

Un homme de 58 ans, fumeur (40 UPA), consulte pour une « boule » au-dessus de la clavicule gauche remarquée il y a 3 semaines. Ganglion de 1,5 cm, ferme, indolore, mobile. Pas de fièvre, pas de plaie, pas d'angine. Examen ORL normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Surveillance clinique et contrôle dans 4 semaines

B Amoxicilline-clavulanate 3 × 625 mg/j pendant 10 jours d'essai

C TDM thoraco-abdominale puis prélèvement histologique, sans période d'observation

D Prednisone 20 mg/j pendant une semaine

E Sérologie EBV et test hétérophile

Q2 **EX** **DX.1 vs DX.2** Prise en charge · cabinet

Une femme de 24 ans présente depuis 5 jours une douleur dentaire (molaire inférieure droite) et un ganglion sous-maxillaire droit de 1,8 cm, sensible, élastique, mobile, peau légèrement chaude. Température 37,9 °C. Pas de perte de poids ni de sueurs nocturnes.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Traiter la porte d'entrée dentaire et réexaminer le ganglion à 3 à 4 semaines
- **B** Biopsie-exérèse du ganglion dans la semaine
- **C** TEP-TDM corps entier
- **D** Cytoponction à l'aiguille fine d'emblée
- **E** Prednisone courte pour réduire l'inflammation

Q3 **EX** **DX.2 🚩E2 · persistance** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 46 ans a un ganglion cervical jugulaire de 2,2 cm apparu il y a 7 semaines, sans porte d'entrée retrouvée. Un traitement antibiotique n'a rien changé. L'échographie montre un ganglion rond, sans hile graisseux visible.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Cytoponction à l'aiguille fine et arrêt du bilan si elle est négative
- **B** Nouvelle période d'observation de 4 semaines
- **C** Biopsie-exérèse du ganglion le plus anormal (histologie, immunohistochimie, part fraîche, mycobactéries)
- **D** Deuxième antibiotique à spectre élargi
- **E** IRM cervicale avant toute décision

Q4 **EX** **DX.2 🚩 compression médiastinale** Prise en charge · urgences

Un homme de 31 ans arrive aux urgences pour une dyspnée croissante depuis 4 jours, une voix rauque et un visage bouffi le matin. Il a des adénopathies cervicales et sus-claviculaires dures et confluentes. SpO_2 92 % à l'air ambiant, stridor discret en décubitus.

Quelle est la priorité immédiate ?

- **A** Biopsie-exérèse programmée en ambulatoire dans la semaine
- **B** Prednisone 60 mg/j et contrôle à la consultation dans 7 jours
- **C** Position assise, oxygène, voie veineuse, imagerie thoracique en urgence et appel immédiat de l'hématologue
- **D** Échographie cervicale ambulatoire
- **E** Amoxicilline-clavulanate et revoir à 3 semaines

Q5 **EX** **DX.13 🚩E5 · DX.14 · ≥ 2 régions** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 29 ans consulte pour une fatigue depuis 3 semaines. Vous palpez des ganglions cervicaux, axillaires et inguinaux de 1,5 cm, mobiles, peu sensibles. Il a eu des rapports non protégés avec un nouveau partenaire il y a 6 semaines. Pas de splénomégalie.

Quel bilan de première intention est le plus approprié ?

- **A** Biopsie-exérèse d'un ganglion inguinal
- **B** Surveillance de 4 semaines sans examen
- **C** TEP-TDM corps entier
- **D** Test VIH combiné de 4e génération, sérologies syphilis, EBV et CMV, hémogramme
- **E** Anticorps antinucléaires isolés

Q6 **EX** **DX.1 · ganglion normal** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 35 ans, en bonne santé, a senti une petite « bille » dans le pli de l'aine droite. Vous trouvez un ganglion inguinal de 1,2 cm, souple, mobile, indolore. Pas d'autre ganglion, pas de lésion des jambes ni du périnée, pas de symptômes généraux.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Échographie inguinale dans la semaine
- **B** Biopsie-exérèse
- **C** Sérologies VIH et syphilis
- **D** TDM abdomino-pelvienne
- **E** Rassurer : variante normale, aucun examen ; reconsulter si le ganglion grossit ou durcit

Q7 **AP** **DX.2 · mécanisme** Mécanismes · cours

On compare deux ganglions cervicaux : le premier est sensible, élastique, avec hile graisseux conservé à l'échographie ; le second est dur, fixé, indolore, rond, sans hile.

Quel mécanisme explique le mieux l'aspect du second ganglion ?

- **A** Une distension capsulaire rapide par hyperplasie réactive
- **B** Une prolifération clonale ou métastatique qui détruit l'architecture ganglionnaire
- **C** Une hyperplasie folliculaire B en réponse à un antigène du territoire
- **D** Un œdème lymphatique par obstruction d'aval
- **E** Une activation macrophagique avec chaleur locale

Q8 **AP** **DX.11 · anatomie** Mécanismes · cours

Chez un patient de 63 ans, on palpe un ganglion sus-claviculaire gauche (ganglion de Virchow).

Pourquoi ce siège gauche oriente-t-il classiquement vers un cancer abdominal ?

- **A** Le ganglion gauche draine exclusivement le poumon gauche
- **B** Le canal thoracique, qui draine la lymphe abdominale, se jette dans l'angle veineux gauche
- **C** Le nerf phrénique gauche transporte les cellules tumorales
- **D** La veine cave inférieure longe le creux sus-claviculaire gauche
- **E** Le ganglion gauche est le relais unique de la thyroïde

Q9 **EX** **DX.12 🚩E4 vs DX.11** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 34 ans, arrivé d'une région à forte incidence de tuberculose il y a 2 ans, présente un ganglion cervical de 3 cm, froid, indolore, avec une fistule cutanée qui suinte. Sueurs nocturnes. Radiographie de thorax en cours.

Quel examen est le plus utile pour établir le diagnostic ?

- **A** IGRA sanguin seul
- **B** Incision-drainage de la fistule sans prélèvement
- **C** Sérologie Bartonella
- **D** Test hétérophile
- **E** PCR et culture mycobactériennes sur ponction ou biopsie du ganglion

Q10 **EX** **DX.15 🚩E1 vs DX.6** Évaluation / diagnostic · pédiatrie

Un garçon de 3 ans a de la fièvre à 39,5 °C depuis 5 jours malgré le paracétamol. Il a les yeux rouges sans sécrétion, les lèvres rouges et fissurées, une éruption polymorphe du tronc et un ganglion cervical unilatéral de 2 cm. Il est très irritable.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Maladie de Kawasaki complète
- **B** Pharyngite à streptocoque du groupe A
- **C** Mononucléose infectieuse à EBV
- **D** Adénopathie réactionnelle d'une infection ORL
- **E** Primo-infection VIH

Q11 **EX** **DX.10 vs DX.13** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 41 ans, traité par phénytoïne depuis 3 semaines après un traumatisme crânien, présente une fièvre à 38,8 °C, une éruption maculeuse diffuse, des adénopathies cervicales et axillaires. Éosinophiles 1,8 G/L, ALAT 3 fois la norme. Pas d'exposition sexuelle à risque.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- **A** Primo-infection VIH
- **B** Mononucléose infectieuse
- **C** Réaction d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) à la phénytoïne
- **D** Lymphome non hodgkinien
- **E** Syphilis secondaire

② Discriminer · 43 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 15 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

Q12 **EX** **DX.4 vs DX.6** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une étudiante de 18 ans a depuis 6 jours une angine exsudative, de la fièvre et une grande fatigue. Ganglions cervicaux postérieurs bilatéraux, rate palpable. Hémogramme : lymphocytes 55 %, lymphocytes atypiques 15 %.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Pharyngite à streptocoque du groupe A
- **B** Mononucléose infectieuse à EBV
- **C** Infection à cytomégalovirus
- **D** Toxoplasmose ganglionnaire
- **E** Leucémie aiguë

Q13 **EX** **DX.4 vs DX.5** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un lycéen de 16 ans a un tableau typique de mononucléose depuis 3 jours (angine, fièvre, ganglions cervicaux postérieurs). Le test hétérophile rapide est négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Conclure que la mononucléose est exclue et chercher un lymphome
- **B** Prescrire de l'amoxicilline pour une angine bactérienne présumée
- **C** Demander une sérologie EBV (VCA-IgM, EBNA) ou répéter le test plus tard
- **D** Sérologie CMV comme seul examen
- **E** Biopsie-exérèse d'un ganglion postérieur

Q14 **EX** **DX.5 vs DX.4** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 32 ans a depuis 12 jours une fièvre, une fatigue intense, une angine discrète et des ganglions cervicaux. Lymphocytes atypiques 14 %, ALAT 2 fois la norme. Test hétérophile négatif ; sérologie EBV : VCA-IgM négatif, EBNA positif.

Quel examen est le plus approprié ensuite ?

- **A** Répéter le test hétérophile dans 1 semaine
- **B** Biopsie-exérèse ganglionnaire
- **C** PCR CMV sanguine et traitement si faiblement positive
- **D** Sérologie CMV (IgM et IgG) avec avidité des IgG
- **E** Test rapide streptocoque

Q15 **EX** **DX.5** Prise en charge · cabinet

Une infirmière de 28 ans, non enceinte, immunocompétente, a une primo-infection à CMV prouvée (séroconversion IgG). Fièvre modérée, fatigue, ALAT 1,5 fois la norme. Elle va bien par ailleurs.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Traitement symptomatique par paracétamol, sans antiviral
- **B** Valganciclovir 900 mg 2 fois par jour pendant 21 jours
- **C** Ganciclovir IV 5 mg/kg toutes les 12 h
- **D** Amoxicilline 10 jours
- **E** Prednisone 30 mg/j

Q16 **EX** **DX.6 vs DX.4** Évaluation / diagnostic · cabinet de pédiatrie

Une fillette de 9 ans a depuis hier une fièvre à 38,6 °C, une odynophagie, pas de toux. Amygdales tuméfiées avec exsudat, ganglions cervicaux antérieurs douloureux. Pas de rate palpable.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Antibiotique d'emblée sur le score clinique seul
- **B** Test de diagnostic rapide (TDR) du streptocoque, antibiotique seulement s'il est positif
- **C** Test hétérophile
- **D** Dosage des ASLO
- **E** Aucun test : angine virale probable

Q17 **EX** **DX.6** Évaluation / diagnostic · cabinet de pédiatrie

Un garçon de 7 ans a 4 critères de Centor (fièvre, pas de toux, exsudat, ganglions cervicaux antérieurs douloureux). Le TDR du streptocoque revient négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Conclure à une angine virale sans autre test
- **B** Amoxicilline 10 jours malgré le test négatif
- **C** Dosage des ASLO
- **D** Culture pharyngée
- **E** Test hétérophile systématique

Q18 **EX** **DX.1 vs DX.8** Prise en charge · cabinet

Un jardinier de 50 ans s'est blessé à l'avant-bras droit avec un rosier il y a 6 jours. La plaie est rouge et chaude ; un ganglion axillaire droit de 2 cm est sensible et mobile. Pas de contact avec des chats. Fonction rénale normale, 80 kg, pas d'allergie.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI IM dose unique
- **B** Azithromycine 500 mg/j pendant 3 jours
- **C** Amoxicilline-clavulanate 3 × 625 mg par jour, puis réexamen du ganglion à 3 à 4 semaines
- **D** Prednisone courte
- **E** Biopsie-exérèse du ganglion axillaire

Q19 **EX** **DX.2 🚩E2 vs DX.12** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 67 ans a perdu 9 kg en 4 mois (12 % de son poids), a des sueurs nocturnes et de la fièvre vespérale. Ganglions cervicaux et axillaires bilatéraux, durs, indolores ; rate palpable. IGRA négatif il y a 2 semaines.

Quelle est la démarche la plus appropriée ?

- **A** Cytoponction cervicale et conclusion si elle est négative
- **B** Prednisone 40 mg/j pour les symptômes B
- **C** TEP-TDM d'emblée sans histologie
- **D** Hémogramme et LDH, puis biopsie-exérèse du ganglion le plus anormal, sans corticoïde préalable
- **E** Traitement antituberculeux d'épreuve

Q20 **EX** **DX.3 vs DX.9** Évaluation / diagnostic · hôpital

La biopsie-exérèse d'un ganglion cervical de 2,5 cm chez une femme de 38 ans revient : « inflammation granulomateuse non nécrosante ». La radiographie montre des adénopathies hilaires. L'IGRA est négatif.

Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?

- **A** Compléter par PCR et culture mycobactériennes (et fongiques) avant de retenir une sarcoïdose
- **B** Retenir une sarcoïdose et débuter la prednisone
- **C** Conclure que la tuberculose est exclue par l'IGRA négatif
- **D** Arrêter le bilan : granulome bénin
- **E** Anticorps antinucléaires seuls

Q21 **EX** **DX.3 vs DX.12** Évaluation / diagnostic · hôpital

La biopsie d'un ganglion cervical froid chez un homme de 45 ans montre des granulomes avec nécrose caséeuse centrale.

Vers quelle cause l'histologie oriente-t-elle d'abord ?

- **A** Une sarcoïdose
- **B** Un lupus érythémateux
- **C** Un pseudolymphome médicamenteux
- **D** Une hyperplasie réactive banale
- **E** Une infection, en premier lieu la tuberculose

Q22 **EX** **DX.7 vs DX.4** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 27 ans, non enceinte, a depuis 3 semaines une fébricule et deux ganglions occipitaux et cervicaux postérieurs de 1,5 cm, indolores. Elle a adopté deux chats et mange volontiers du tartare. Sérologie toxoplasmose : IgM positives, IgG positives.

Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?

- **A** Conclure à une toxoplasmose aiguë sur les IgM
- **B** Pyriméthamine + sulfadiazine + acide folinique
- **C** Biopsie-exérèse immédiate
- **D** Demander l'avidité des IgG anti-toxoplasme
- **E** Sérologie Bartonella seule

Q23 **EX** **DX.7** Prise en charge · cabinet

Une femme de 27 ans, immunocompétente, non enceinte, a une toxoplasmose ganglionnaire récente confirmée (IgG de faible avidité). Fond d'œil normal. Elle va bien.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée ?

- **A** Pyriméthamine 100 mg puis 25–50 mg/j + sulfadiazine + acide folinique pendant 3 à 6 semaines
- **B** Cotrimoxazole
- **C** Azithromycine 3 jours
- **D** Prednisone
- **E** Abstention thérapeutique et surveillance du ganglion

Q24 **EX** **DX.8 vs DX.7** Évaluation / diagnostic · cabinet de pédiatrie

Un garçon de 8 ans a un ganglion axillaire gauche de 3 cm, sensible, apparu il y a 10 jours. Sa famille a adopté un chaton ; il y a 3 semaines, une petite papule est apparue sur son avant-bras gauche griffé. Apyrétique, état général conservé.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Toxoplasmose ganglionnaire
- **B** Tuberculose ganglionnaire
- **C** Lymphome
- **D** Maladie de Kawasaki
- **E** Maladie des griffes du chat (Bartonella henselae)

Q25 **EX** **DX.9 vs DX.3** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 30 ans consulte pour des nodules rouges douloureux des jambes, une fièvre à 38 °C et des chevilles gonflées et douloureuses depuis 10 jours. La radiographie de thorax montre des adénopathies hilaires bilatérales.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Biopsie ganglionnaire médiastinale obligatoire
- **B** Prednisone 60 mg/j d'emblée
- **C** Quadrithérapie antituberculeuse
- **D** Retenir un syndrome de Löfgren sur le tableau clinique, sans biopsie
- **E** TEP-TDM pour exclure un lymphome

Q26 **EX** **DX.9 vs DX.11** Prise en charge · cabinet

Une femme de 44 ans, suivie pour un lupus érythémateux systémique stable, présente un ganglion sus-claviculaire droit de 2 cm, dur, indolore, apparu en un mois.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attribuer le ganglion à une poussée de lupus et augmenter la prednisone
- **B** Surveillance de 4 semaines
- **C** Dosage des anticorps anti-ADN natif pour confirmer la poussée
- **D** Biopsie sans attendre, après imagerie
- **E** Hydroxychloroquine à dose majorée

Q27 **EX** **DX.10** Prise en charge · hôpital

Un homme de 41 ans sous phénytoïne depuis 3 semaines présente un DRESS probable (fièvre, éruption, adénopathies, éosinophilie, cytolyse hépatique). Il n'a pas fait de crise depuis son traumatisme crânien.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Poursuivre la phénytoïne et ajouter un antihistaminique
- **B** Arrêter la phénytoïne immédiatement et organiser un relais antiépileptique avec le neurologue
- **C** Remplacer la phénytoïne par la carbamazépine
- **D** Biopsie-exérèse avant toute décision thérapeutique
- **E** Réduire la dose de moitié en surveillant le taux plasmatique

Q28 **EX** **DX.10 vs DX.2** Évaluation / diagnostic · cabinet

Chez un patient dont la phénytoïne a été arrêtée il y a 7 semaines pour une hypersensibilité, un ganglion cervical de 2,5 cm ne régresse pas. Les autres signes ont disparu.

Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?

- **A** Rassurer : le pseudolymphome médicamenteux peut persister des mois
- **B** Réintroduire la phénytoïne pour tester l'imputabilité
- **C** Prednisone pour accélérer la régression
- **D** Biopsie-exérèse du ganglion
- **E** Répéter l'hémogramme dans 2 mois

Q29 **EX** **DX.11 🚩E3** Évaluation / diagnostic · hôpital

Chez un homme de 61 ans avec un ganglion sus-claviculaire droit de 2 cm, la ponction à l'aiguille fine revient « non diagnostique ». La TDM montre un ganglion isolé.

Quelle est l'étape suivante la plus appropriée ?

- **A** Conclure à un ganglion bénin et surveiller
- **B** Antibiotique d'essai de 2 semaines
- **C** TEP-FDG comme examen final
- **D** Prednisone d'épreuve
- **E** Biopsie chirurgicale d'exérèse du ganglion

Q30 **EX** **DX.12** Prise en charge · cabinet

Un homme de 34 ans a une tuberculose ganglionnaire cervicale isolée prouvée (culture positive, souche sensible). Radiographie de thorax et expectorations négatives. Test VIH négatif.

Quel schéma thérapeutique standard est le plus approprié ?

- **A** 2 mois de quadrithérapie seulement
- **B** Isoniazide seul pendant 9 mois
- **C** 6 mois : 2 mois de rifampicine-isoniazide-pyrazinamide-éthambutol, puis 4 mois de rifampicine-isoniazide
- **D** Exérèse chirurgicale sans antituberculeux
- **E** Rifampicine-isoniazide 12 mois sans phase intensive

Q31 **EX** **DX.13 🚩E5 vs DX.4** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 24 ans ayant des rapports avec des hommes consulte 3 semaines après un rapport anal non protégé : fièvre à 38,7 °C, angine, éruption maculeuse du tronc, adénopathies cervicales et axillaires, aphtes.

Quel examen est le plus approprié ?

- **A** Test hétérophile seul
- **B** Test VIH combiné de 4e génération, complété par l'ARN du VIH (charge virale)
- **C** Autotest VIH rapide
- **D** Biopsie-exérèse ganglionnaire
- **E** Aucun test avant 3 mois

Q32 **EX** **DX.13** Prise en charge · cabinet

Chez un homme de 24 ans, l'ARN du VIH-1 est élevé et le test combiné positif. Le génotype de résistance est demandé, résultat attendu dans 10 jours. Méningite, sepsis et infection opportuniste sont exclus.

Quand débuter le traitement antirétroviral ?

- **A** Le jour même du diagnostic, sans attendre le génotype
- **B** Après le résultat du génotype
- **C** Quand les CD4 passent sous 350/µL
- **D** Après séroconversion complète au Western blot
- **E** Après 3 mois pour laisser le système immunitaire contrôler le virus

Q33 **EX** **DX.14 🚩E6 vs DX.13** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 37 ans a depuis 2 semaines une éruption de macules rosées sur les paumes et les plantes, non prurigineuse, des adénopathies cervicales, axillaires et épitrochléennes, et une fébricule. Il se souvient d'une « petite plaie » génitale indolore il y a 2 mois.

Quels examens posent le diagnostic ?

- **A** Un test tréponémique seul
- **B** Un test non tréponémique seul
- **C** Une biopsie cutanée
- **D** Le test VIH comme unique examen
- **E** Un test tréponémique et un test non tréponémique avec titre

Q34 **EX** **DX.14** Prise en charge · cabinet

Un homme de 37 ans a une syphilis secondaire confirmée, sans atteinte neurologique, oculaire ni otique. Pas d'allergie. Test VIH négatif.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Benzathine benzylpénicilline 1,2 MUI IM dose unique
- **B** Benzathine benzylpénicilline 2,4 MUI IM une fois par semaine pendant 3 semaines
- **C** Amoxicilline-clavulanate 10 jours
- **D** Pénicilline G intraveineuse 14 jours
- **E** Benzathine benzylpénicilline (Extencilline®) 2,4 MUI IM en dose unique, et traitement des partenaires récents

Q35 **EX** **DX.15** 🚩**E1** Prise en charge · pédiatrie

Un garçon de 3 ans au Kawasaki complet est au 6e jour de fièvre. L'échocardiographie n'est disponible que demain matin.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre l'échocardiographie avant tout traitement
- **B** Prednisone seule
- **C** Antibiothérapie IV pour une infection bactérienne
- **D** Immunoglobulines IV 2 g/kg en dose unique avec acide acétylsalicylique, sans attendre l'échocardiographie
- **E** Acide acétylsalicylique seul en ambulatoire

Q36 **AP** **DX.3 · enfant** Évaluation / diagnostic · pédiatrie

Un garçon de 3 ans, en bonne santé, a un ganglion sous-mandibulaire de 3 cm, indolore, violacé, évoluant depuis 6 semaines. La biopsie montre des granulomes nécrosants ; pas de contage tuberculeux.

Quelle cause est la plus fréquente de ce tableau granulomateux chez l'enfant ?

- **A** Mycobacterium tuberculosis
- **B** La sarcoïdose
- **C** La toxoplasmose
- **D** Le lupus érythémateux
- **E** Une mycobactérie non tuberculeuse

Q37 **AP** **DX.5 · sérologie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 30 ans a des IgM anti-CMV positives sur un bilan de fatigue. Les IgG sont positives.

Quel examen permet le mieux de dater l'infection ?

- **A** Le titre des IgM
- **B** Le test hétérophile
- **C** L'avidité des IgG anti-CMV
- **D** La PCR CMV sanguine
- **E** Le dosage des transaminases

Q38 **AP** **DX.6 · allergie** Prise en charge · cabinet

Un homme de 27 ans a une pharyngite à streptocoque prouvée (TDR positif). Il a fait un œdème de Quincke sous pénicilline il y a 5 ans.

Quel antibiotique est le plus approprié ?

- **A** Céfuroxime 250 mg 2 fois par jour
- **B** Clindamycine 300 mg 2 fois par jour pendant 10 jours
- **C** Amoxicilline 750 mg 3 fois par jour
- **D** Benzathine benzylpénicilline 1,2 MUI IM
- **E** Ceftriaxone 2 g/j

Q39 **AP** **DX.7 · pharmacologie** Mécanismes · hôpital

Une patiente immunodéprimée reçoit pyriméthamine + sulfadiazine pour une toxoplasmose. L'interne propose de donner de l'acide folique plutôt que de l'acide folinique, « c'est pareil et moins cher ».

Pourquoi faut-il l'acide FOLINIQUE ?

- **A** La pyriméthamine inhibe la dihydrofolate réductase : seul un folate déjà réduit (folinate) contourne le blocage
- **B** L'acide folique potentialiserait la toxicité rénale de la sulfadiazine
- **C** L'acide folique est contre-indiqué chez l'immunodéprimé
- **D** Le folinate tue directement le parasite
- **E** L'acide folique inactive la pyriméthamine dans l'intestin

Q40 AP DX.10 · réaction croisée Prise en charge · hôpital question négative

Après un DRESS à la phénytoïne, le neurologue cherche un antiépileptique de relais.

Quel antiépileptique faut-il éviter en raison d'une réaction croisée connue ?

A Carbamazépine

B Lévétiracétam

C Valproate

D Clobazam

E Lacosamide

Q41 AP DX.12 · réaction paradoxale Prise en charge · cabinet

Un patient traité depuis 7 semaines pour une tuberculose ganglionnaire cervicale sensible, observant, voit son ganglion grossir et devenir fluctuant. Il va bien, sans fièvre ; la culture du pus est négative.

Quelle est l'interprétation la plus probable ?

A Un échec thérapeutique par résistance

B Une réaction paradoxale : on poursuit le traitement et on demande un avis

C Un lymphome associé, à exclure par l'arrêt du traitement

D Une toxicité de l'éthambutol

E Une indication à une incision large

Q42 **AP** **DX.13 · U=U** Mécanismes · cabinet

Un homme de 40 ans, séropositif, traité depuis 2 ans, a un ARN du VIH indétectable de façon stable. Son partenaire séronégatif demande s'il risque une transmission sexuelle.

Quelle réponse est la plus juste ?

- **A** Oui, le risque reste celui d'un patient non traité
- **B** Non : avec un ARN durablement indétectable, le VIH ne se transmet pas par voie sexuelle (U=U)
- **C** Oui, sauf si le partenaire prend une PEP après chaque rapport
- **D** Le risque dépend uniquement des CD4
- **E** Non, mais seulement si les anticorps ont disparu

Q43 **AP** **DX.14 · Jarisch-Herxheimer** Prise en charge · cabinet

Quatre heures après l'injection d'Extencilline® 2,4 MUI pour une syphilis secondaire, le patient rappelle : frissons, fièvre à 38,9 °C, céphalées, éruption plus visible. Pas de dyspnée, pas d'urticaire.

Quelle est l'explication et la conduite la plus appropriées ?

- **A** Réaction de Jarisch-Herxheimer : rassurer et donner un antipyrétique
- **B** Allergie à la pénicilline : adrénaline et contre-indication définitive
- **C** Échec du traitement : 2e injection immédiate
- **D** Neurosyphilis : pénicilline G IV en urgence
- **E** Primo-infection VIH : test combiné en urgence

Q44 **AP** **DX.15 · résistance IVIG** Prise en charge · pédiatrie

Un enfant de 4 ans avec Kawasaki a reçu des immunoglobulines 2 g/kg et de l'aspirine. 40 heures après la fin de la perfusion, la fièvre persiste à 39 °C.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Attendre 7 jours de plus
- **B** Retenir une résistance aux immunoglobulines : ajouter un corticoïde ou une deuxième cure
- **C** Ajouter de l'ibuprofène
- **D** Antibiothérapie IV
- **E** Arrêter l'aspirine

Q45 **SPE · Hématologie** **DX.2 · Lugano** Évaluation / diagnostic · hématologie

Un lymphome de Hodgkin est confirmé chez une femme de 34 ans. Le PET-TDM montre des ganglions cervicaux et médiastinaux, ainsi que des ganglions rétropéritonéaux ; pas d'atteinte extra-ganglionnaire.

Quel stade de Lugano retenez-vous ?

- **A** Stade I
- **B** Stade III
- **C** Stade II
- **D** Stade IV
- **E** Stade non déterminable sans biopsie médullaire

Q46 **SPE · Pneumologie** **DX.3 · sarcoïdose** Évaluation / diagnostic · pneumologie

Une sarcoïdose ganglionnaire médiastinale est retenue chez un homme de 42 ans après exclusion des infections.

Quel examen de base a une recommandation forte dans le bilan initial ?

- **A** Le dosage de l'ECA comme critère diagnostique
- **B** Le TEP-TDM systématique
- **C** La calcémie
- **D** La biopsie médullaire
- **E** L'IGRA répété tous les 3 mois

Q47 **SPE · Infectiologie** **DX.7 · encéphalite** Prise en charge · infectiologie

Un patient VIH avec CD4 effondrés a des lésions cérébrales annulaires à l'IRM et des IgG anti-toxoplasme positives. Il a une allergie documentée aux sulfamides.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Pyriméthamine + clindamycine + acide folinique, sans attendre la PCR
- **B** Pyriméthamine + sulfadiazine
- **C** Attendre la PCR avant tout traitement
- **D** Pyriméthamine seule
- **E** Cotrimoxazole

Q48 **SPE · Ophtalmologie** **DX.8 · œil** Évaluation / diagnostic · ophtalmologie

Une fillette de 10 ans, griffée par un chat il y a un mois, se plaint d'une baisse de vision unilatérale. Le fond d'œil montre un œdème papillaire et une étoile maculaire.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- **A** Choriorétinite toxoplasmique
- **B** Hypertension intracrânienne idiopathique
- **C** Neurorétinite à Bartonella henselae
- **D** Rétinite à CMV
- **E** Syndrome de Löfgren

Q49 **SPE · Rhumatologie** **DX.9 · méthotrexate** Prise en charge · rhumatologie

Une patiente de 55 ans traitée pour polyarthrite rhumatoïde par méthotrexate développe un nouveau ganglion axillaire de 2,5 cm, ferme, indolore.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Augmenter le méthotrexate : la polyarthrite est active
- **B** Passer le méthotrexate en prise quotidienne
- **C** Ajouter prednisone 30 mg/j
- **D** Arrêter le méthotrexate, demander un avis spécialisé et biopsier le ganglion
- **E** Surveillance de 3 mois

Q50 **SPE · Neurologie** **DX.10 · pharmacogénétique** Mécanismes · neurologie

Avant de prescrire la phénytoïne à un patient d'origine chinoise Han, le neurologue évoque un test génétique.

Quel allèle augmente le risque de syndrome de Stevens-Johnson sous phénytoïne selon l'AIPS ?

- **A** HLA-B*5801
- **B** HLA-B27
- **C** HLA-B*1502
- **D** HLA-DR4
- **E** HLA-A*0201

Q51 **SPE · Pneumologie** **DX.12 · rifampicine** Prise en charge · pneumologie

Une femme de 26 ans débute un traitement HRZE pour une tuberculose ganglionnaire. Elle prend une pilule œstroprogestative.

Quel conseil est le plus approprié ?

- **A** Garder la pilule, sans précaution
- **B** Doubler la dose de pilule
- **C** Passer à une contraception non hormonale pendant le traitement par rifampicine
- **D** Arrêter la rifampicine pour garder la pilule
- **E** Remplacer la rifampicine par l'éthambutol seul

Q52 **SPE · Infectiologie** **DX.13 · Fiebig** Mécanismes · infectiologie

Chez un patient exposé il y a 9 jours, l'ARN du VIH-1 est détectable, l'antigène p24 et les anticorps sont négatifs.

À quel stade de Fiebig correspond ce profil ?

- **A** Stade I
- **B** Stade II
- **C** Stade III
- **D** Stade V
- **E** Stade VI

Q53 **SPE · Dermato-vénéréologie** **DX.14 · neurosyphilis** Prise en charge · dermato-vénéréologie

Un patient avec syphilis secondaire décrit une baisse d'audition et des céphalées ; la ponction lombaire confirme une neurosyphilis.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Extencilline® 2,4 MUI IM dose unique
- **B** Extencilline® 2,4 MUI IM par semaine pendant 3 semaines
- **C** Doxycycline 100 mg 2 fois par jour pendant 2 semaines
- **D** Pénicilline G intraveineuse
- **E** Amoxicilline-clavulanate 10 jours

Q54 **SPE · Cardiologie pédiatrique** **DX.15 · coronaires** Prise en charge · cardiologie pédiatrique

Chez un enfant de 6 ans avec Kawasaki, l'échocardiographie montre une artère coronaire avec Z-score à 11 (diamètre 8,5 mm).

Quel traitement antithrombotique est le plus approprié ?

- **A** Aspirine à faible dose pendant 4 à 6 semaines seulement
- **B** Aspirine associée à une anticoagulation (phenprocoumone INR 2,0–3,0 ou énoxaparine)
- **C** Aspirine à faible dose au long cours seule
- **D** Aspirine avec ou sans clopidogrel
- **E** Aucun traitement si l'enfant est asymptomatique

🚩 Pièges & alarmes · 9 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Corticoïde avant biopsie, blastes, amoxicilline et mononucléose, IGRA négatif, fenêtre VIH, Kawasaki incomplet.

Q55 **EX** **DX.2 🚩 corticoïde** Prise en charge · cabinet

Un homme de 52 ans a des ganglions cervicaux de 2 cm depuis 6 semaines, sans diagnostic. Il demande « une cortisone pour faire dégonfler », comme un ami qui « avait la même chose ».

Quelle est la réponse la plus appropriée ?

- **A** Prednisone 20 mg/j pendant 5 jours puis réévaluer
- **B** Prednisone si l'échographie est rassurante
- **C** Corticoïde local injecté dans le ganglion
- **D** Dexaméthasone en une seule dose
- **E** Refuser tout corticoïde avant la biopsie, car il peut masquer un lymphome

Q56 **EX** **DX.2 🚩 cytopénie** Prise en charge · cabinet

Un homme de 22 ans consulte pour des ganglions cervicaux et une grande fatigue. L'hémogramme montre hémoglobine 82 g/L, plaquettes 38 G/L et des blastes au frottis.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Test hétérophile et contrôle de l'hémogramme dans 2 semaines
- **B** Biopsie-exérèse programmée en ambulatoire
- **C** Avis hématologique le jour même
- **D** Supplément de fer et contrôle à 1 mois
- **E** Échographie cervicale

Q57 **EX** **DX.4** Prise en charge · cabinet

Un joueur de rugby de 19 ans a une mononucléose confirmée depuis 8 jours ; rate palpable. Il veut rejouer le match du week-end prochain.

Quel conseil est le plus approprié ?

- **A** Reprise autorisée dès l'apyrexie
- **B** Reprise autorisée avec une protection abdominale
- **C** Reprise après une cure courte de corticoïde
- **D** Reprise si le test hétérophile se négative
- **E** Pas de sport de contact pendant au moins 3 semaines, parfois jusqu'à disparition de la splénomégalie

Q58 EX DX.4 vs DX.6 Prise en charge · cabinet question négative

Une jeune femme de 20 ans a une angine exsudative fébrile, des ganglions cervicaux postérieurs et une splénomégalie. Le TDR streptocoque est négatif, le test hétérophile positif.

Quel médicament est contre-indiqué ?

A Paracétamol

B Ibuprofène

C Solution de réhydratation orale

D Amoxicilline

E Pastilles de lidocaïne pour la gorge

Q59 EX DX.8 Prise en charge · cabinet de pédiatrie

Un garçon de 8 ans avec maladie des griffes du chat typique revient : le ganglion axillaire est devenu fluctuant et très douloureux. Apyrétique, immunocompétent.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Incision-drainage chirurgicale

B Aspiration à l'aiguille pour soulager la douleur

C Exérèse chirurgicale du ganglion

D Gentamicine IV

E Prednisone

Q60 EX DX.12 🚩E4 Évaluation / diagnostic · hôpital

Chez une femme de 29 ans née en Érythrée, la ponction d'un ganglion cervical froid montre un granulome caséeux. L'IGRA est négatif ; l'interne propose de « classer la tuberculose ».

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Poursuivre : PCR et culture mycobactériennes sur le prélèvement

B Exclure la tuberculose sur l'IGRA négatif

C Retenir une sarcoïdose

D Répéter l'IGRA dans 3 mois

E Débuter une prednisone pour le ganglion

Q61 EX DX.12 Prise en charge · cabinet question négative

Une femme de 31 ans, enceinte de 14 semaines, a une tuberculose ganglionnaire prouvée. Vous préparez le schéma avec le pneumologue.

Quel antituberculeux l'AIPS interdit-il pendant la grossesse ?

A Rifampicine

B Isoniazide

C Éthambutol

D Pyridoxine

E Pyrazinamide

Q62 **EX** **DX.13 🚩E5** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 33 ans consulte 10 jours après un rapport non protégé avec un partenaire de statut inconnu. Il a de la fièvre, une angine et des ganglions cervicaux. Le test VIH combiné de 4e génération est négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Doser l'ARN du VIH et répéter le test combiné à 2–4 semaines
- **B** Rassurer : le VIH est exclu
- **C** Débuter une PrEP immédiatement
- **D** Démarrer une PEP
- **E** Test hétérophile et arrêt du bilan VIH

Q63 **EX** **DX.15 🚩E1 · forme incomplète** Évaluation / diagnostic · pédiatrie

Un nourrisson de 5 mois a de la fièvre depuis 7 jours sans foyer. CRP 120 mg/L. Il ne remplit aucun critère clinique complet de Kawasaki ; urines, hémocultures et radiographie sont négatives.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Échocardiographie et algorithme de forme incomplète de Kawasaki
- **B** Exclure le Kawasaki faute de 4 critères
- **C** Poursuivre la surveillance de la fièvre jusqu'au 10e jour
- **D** Antibiothérapie IV empirique seule
- **E** Biopsie ganglionnaire

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
0 · Dyspnée, stridor, œdème du visage	Urgence : voies aériennes, imagerie, hématologie (compression médiastinale)
E1 · Enfant fébrile ≥ 5 jours, 4 critères sur 5	DX.15 : immunoglobulines 2 g/kg + aspirine, échocardiographie sans retarder

E2 · Dur, fixe, symptômes B, splénomégalie	DX.2 : hémogramme, LDH, biopsie-exérèse, pas de corticoïde
E3 · Creux sus-claviculaire	DX.11 : TDM, biopsie, sans observation
E4 · Fistule, contage, sueurs	DX.12 : PCR, culture, précautions de transmission
E5 · Exposition sexuelle, fièvre, éruption	DX.13 : test 4e génération + ARN
E6 · Éruption palmo-plantaire	DX.14 : sérologies, Extencilline® 2,4 MUI IM
Médicament récent, fièvre, éruption	DX.10 : arrêt (relais si antiépileptique)
Angine fébrile, Centor 3–4	DX.6 : TDR, antibiotique si positif (culture si TDR négatif chez l'enfant)
Angine, fatigue, rate, ganglions postérieurs	DX.4 ou DX.5 : hétérophile, sérologie ; jamais d'amoxicilline
Chat, papule, ganglion régional	DX.8 : clinique, sérologie si doute, surveillance
Granulome, arthralgies, hilaire bilatéral	DX.3, DX.9, DX.7 : histologie + microbiologie, ANA, ECA, sérologie
Plaie ou infection du territoire	DX.1 : traiter, revoir à 3–4 semaines ; au-delà de 4–6 semaines : biopsie

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 EX DX.11 🚩E3 vs DX.1

✅ **C — TDM thoraco-abdominale puis prélèvement histologique, sans période d'observation**

① **Pourquoi c'est juste** Tout ganglion sus-claviculaire palpable est malin jusqu'à preuve du contraire (DX.11, rang E3). À gauche, il oriente vers l'abdomen (ganglion de Virchow) ; la conduite est imagerie et prélèvement dans la semaine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'observation de 3 à 4 semaines vaut pour un ganglion localisé au tableau bénin, jamais pour le creux sus-claviculaire (≈ 50 % de malignité en médecine de famille).
- **B** L'antibiotique d'essai retarde le diagnostic ; ce siège n'est presque jamais réactif.
- **D** Un corticoïde avant la biopsie peut effacer l'image histologique d'un lymphome.
- **E** Le syndrome mononucléosique ne rend pas bénin un ganglion sus-claviculaire ; et rien ici n'oriente vers l'EBV (58 ans, pas d'angine).

③ **Perle** Sus-claviculaire = pas d'observation, pas d'antibiotique d'essai, pas de corticoïde. Chercher d'abord stridor, œdème du visage, dysphagie.

④ **Source** Phase B DX.11 §13 · LOT_002 audité

Q2 EX DX.1 vs DX.2

✅ **A** — Traiter la porte d'entrée dentaire et réexaminer le ganglion à 3 à 4 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Ganglion sensible, élastique, mobile + porte d'entrée dans le territoire de drainage = adénopathie réactionnelle (DX.1). On traite la cause, puis on revoit : le diagnostic est confirmé rétrospectivement par la régression en 3 à 4 semaines.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La biopsie s'impose si le ganglion persiste au-delà de 4 à 6 semaines ou s'il existe un drapeau rouge ; aucun ici.
- **C** Le TEP-TDM sert à stadifier un lymphome confirmé ou à chercher un primitif inconnu, pas à explorer une adénite réactionnelle.
- **D** Inutile devant un ganglion inflammatoire avec porte d'entrée évidente ; elle ne vient qu'en 2e intention après échographie.
- **E** Jamais de corticoïde devant une adénopathie avant d'avoir exclu un lymphome.

③ **Perle** Une amélioration sous antibiotique ne suffit pas à clore le dossier : il faut revoir le ganglion. La douleur seule n'exclut pas un lymphome.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_002 audité

Q3 EX DX.2 🚩E2 · persistance

✅ **C** — Biopsie-exérèse du ganglion le plus anormal (histologie, immunohistochimie, part fraîche, mycobactéries)

① **Pourquoi c'est juste** Persistance au-delà de 4 à 6 semaines + ganglion rond avec perte du hile = indication de biopsie-exérèse, gold standard qui conserve l'architecture (DX.2, rang E2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Précision de la cytoponction ≈ 84 % : un résultat négatif n'exclut pas un lymphome ; il faut l'architecture du ganglion entier.
- **B** Le délai d'observation est déjà dépassé (> 4–6 semaines) et l'échographie est suspecte.
- **D** Un ganglion qui ne régresse pas sous traitement contredit la réaction bénigne ; un 2e essai retarde le diagnostic.
- **E** L'imagerie n'apporte pas l'histologie ; l'échographie a déjà montré les critères de malignité.

③ **Perle** Demandez à la fois histologie avec immunohistochimie, un fragment frais pour cytométrie et un prélèvement pour PCR/culture mycobactériennes : un seul geste pour trancher lymphome, métastase et tuberculose.

④ **Source** Phase A §9.a Gold standard · LOT_002 audité

Q4 **EX** **DX.2 🚩 compression médiastinale**

✅ **C** — Position assise, oxygène, voie veineuse, imagerie thoracique en urgence et appel immédiat de l'hématologue

① **Pourquoi c'est juste** Étape 0 de l'algorithme : dyspnée, stridor, œdème du visage = masse médiastinale compressive. On sécurise voies aériennes, respiration, circulation, puis bilan (hémogramme, LDH, uricémie, créatinine) et hématologue.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La compression médiastinale (dyspnée, stridor, œdème du visage) précède tout le reste de l'algorithme : c'est une urgence vitale.
- **B** Un corticoïde lyse le lymphome et masque l'histologie ; il ne se discute qu'en urgence vitale, décidé avec l'hématologue, pas en ambulatoire.
- **D** L'échographie cervicale n'évalue pas la masse médiastinale et retarde la prise en charge.
- **E** Aucune porte d'entrée ; tableau tumoral compressif.

③ **Perle** Une compression de la veine cave est une urgence vitale. Dans l'ordre : ABC, voie veineuse + bilan de lyse, hospitalisation-hématologie, pas de corticoïde « réflexe » avant le prélèvement.

④ **Source** Phase A §11.B Urgence · LOT_002 audité

Q5 **EX** **DX.13 🚩E5 · DX.14 · ≥ 2 régions**

✅ **D** — Test VIH combiné de 4e génération, sérologies syphilis, EBV et CMV, hémogramme

① **Pourquoi c'est juste** Au moins deux régions atteintes → test VIH, syphilis, EBV, CMV, ANA, hémogramme, échographie (Phase A §10). L'exposition sexuelle place E5 (VIH) et E6 (syphilis) en tête.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Des adénopathies généralisées après exposition imposent d'abord les tests infectieux ; la biopsie vient si le bilan est négatif et que les ganglions persistent.
- **B** Deux régions ou plus = risque relatif de cancer 6,41 et indication d'un bilan étendu ; l'exposition sexuelle impose des tests.
- **C** Le TEP-TDM ne précède pas les sérologies ; il sert à la stadification d'un lymphome confirmé.
- **E** Les ANA font partie du bilan étendu mais ne sont pas prioritaires devant une exposition sexuelle récente.

③ **Perle** Deux régions ganglionnaires atteintes imposent de tester le VIH ET la syphilis : les deux coexistent souvent.

④ **Source** Phase A §10 Arbre décisionnel · LOT_002 audité

Q6 EX DX.1 · ganglion normal

✅ **E** — Rassurer : variante normale, aucun examen ; reconsulter si le ganglion grossit ou durcit

① **Pourquoi c'est juste** Un ganglion normal est < 1 cm, souple, mobile, indolore — mais à l'aine et en sous-maxillaire, 1 à 1,5 cm reste une variante normale. Confondre cette variante avec une adénopathie conduit à des examens inutiles.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les ganglions inguinaux atteignent 1 à 1,5 cm sans maladie : une imagerie ici est un examen inutile.
- **B** Aucun critère de biopsie : ni persistance documentée, ni drapeau rouge, ni imagerie suspecte.
- **C** Pas d'adénopathie généralisée ni d'exposition rapportée ; le ganglion est dans la norme inguinale.
- **D** Irradiation et coût sans indication.

③ **Perle** Expliquez le signe d'alerte : croissance, durcissement, fixation ou persistance → reconsulter. C'est cela, la « surveillance ».

④ **Source** Phase A §1 Notions voisines · LOT_002 audité

Q7 AP DX.2 · mécanisme

✅ **B** — Une prolifération clonale ou métastatique qui détruit l'architecture ganglionnaire

① **Pourquoi c'est juste** L'infiltration tumorale fige et durcit le ganglion ; la prolifération clonale ou la métastase détruit l'architecture, d'où dureté, fixation et perte du hile.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La distension capsulaire explique la DOULEUR d'un ganglion inflammatoire ; l'hyperplasie réactive conserve le hile.
- **C** Réaction bénigne : elle régresse avec la cause et garde l'architecture.
- **D** Non décrit comme cause de ganglion dur sans hile dans le cours.
- **E** La chaleur et la sensibilité signent l'inflammation, pas l'infiltration.

③ **Perle** Le mécanisme prédit l'évolution : l'hyperplasie réactive régresse avec la cause, l'infiltration persiste et progresse. Un ganglion qui grossit ou durcit contredit la réaction bénigne.

④ **Source** Phase A §3.1 Physiopathologie · LOT_002 audité

Q8 AP DX.11 · anatomie

✅ **B** — Le canal thoracique, qui draine la lymphe abdominale, se jette dans l'angle veineux gauche

① **Pourquoi c'est juste** Le côté gauche oriente vers l'abdomen parce que le canal thoracique se jette dans l'angle veineux gauche ; le côté droit oriente vers le thorax.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le côté droit oriente vers le thorax ; le gauche reçoit le canal thoracique.
- **C** Aucun mécanisme nerveux ne dissémine les métastases ganglionnaires.
- **D** Anatomiquement faux ; la veine cave inférieure n'atteint pas le cou.
- **E** La thyroïde draine vers les chaînes cervicales, sans latéralisation abdominale.

③ **Perle** Piège : Virchow ne signe pas toujours un cancer gastrique — dans la série lue, les cancers digestifs ne formaient que 9 % des métastases, le poumon dominait.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_002 audité

Q9 EX DX.12 🚩E4 vs DX.11

✅ **E** — PCR et culture mycobactériennes sur ponction ou biopsie du ganglion

① **Pourquoi c'est juste** Ganglion froid, fistulisé, sueurs, origine endémique = tuberculose ganglionnaire (DX.12, E4). La preuve est bactériologique sur le ganglion : PCR (Xpert) et culture, avec histologie si biopsie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un IGRA positif indique une infection latente ou active, il ne prouve pas la maladie ; négatif, il n'exclut rien (sensibilité ≈ 0,89).
- **B** L'incision d'un abcès froid sans prélèvement crée une fistule chronique ; il faut ponctionner et cultiver.
- **C** Pas de contact avec un chat ; la fistule froide et le contexte orientent vers la tuberculose.
- **D** Le syndrome mononucléosique ne donne pas de ganglion froid fistulisé.

③ **Perle** Toujours chercher une atteinte pulmonaire : la forme ganglionnaire isolée n'est pas contagieuse, la forme pulmonaire associée l'est. Tester aussi le VIH et déclarer à l'OFSP.

④ **Source** Phase B DX.12 §8 · LOT_002 audité

Q10 EX DX.15 🚩E1 vs DX.6

✅ **A** — Maladie de Kawasaki complète

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre ≥ 5 jours + 4 critères sur 5 (conjonctivite non exsudative, atteinte buccale, extrémités, éruption, ganglion cervical ≥ 1,5 cm) = Kawasaki complet (AHA 2017). C'est E1 : le premier DD grave à exclure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Ganglions cervicaux antérieurs sensibles et exsudat, mais pas de conjonctivite bilatérale ni d'atteinte des lèvres et de la peau.
- **C** Pic d'âge 15 à 24 ans ; angine et ganglions postérieurs, sans conjonctivite non exsudative ni lèvres fissurées.
- **D** Elle n'explique pas la fièvre de 5 jours avec conjonctivite, atteinte buccale et éruption.
- **E** Ni exposition ni contexte ; tableau typique des critères AHA.

③ **Perle** Le ganglion doit faire ≥ 1,5 cm et est souvent unilatéral. Avec ≥ 4 critères, surtout extrémités, on peut poser le diagnostic dès le 4e jour.

④ **Source** Phase B DX.15 §8 · LOT_002 audité

Q11 EX DX.10 vs DX.13

✅ **C** — Réaction d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) à la phénytoïne

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre, éruption, adénopathie, éosinophilie, atteinte d'organe 2 à 8 semaines après l'introduction = DRESS (score RegiSCAR). L'AIPS de la phénytoïne cite fièvre et lymphadénopathie comme signes précoces d'hypersensibilité.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Fièvre, éruption et adénopathies, mais pas d'exposition ; l'éosinophilie et la chronologie avec le médicament orientent ailleurs.
- **B** Les lymphocytes atypiques peuvent exister dans les deux, mais l'éosinophilie, l'âge et le délai après le médicament orientent vers le DRESS.
- **D** Installation trop aiguë, avec éosinophilie, atteinte hépatique et chronologie médicamenteuse.
- **E** Pas d'éruption palmo-plantaire décrite, pas d'exposition.

③ **Perle** Toute adénopathie récente impose le recensement de TOUS les médicaments des 3 derniers mois. Délai médian du DRESS ≈ 22 jours ; antiépileptiques = 35 % des cas, allopurinol 18 %.

④ **Source** Phase B DX.10 §8 · LOT_002 audité

Q12 **EX** DX.4 vs DX.6

✅ **B** — Mononucléose infectieuse à EBV

① **Pourquoi c'est juste** Angine + fièvre + ganglions cervicaux postérieurs + splénomégalie chez un 15–24 ans, lymphocytes > 40 % dont > 10 % atypiques = mononucléose (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ganglions cervicaux ANTÉRIEURS sensibles, sans splénomégalie ni lymphocytose atypique ; l'exsudat seul ne tranche pas.
- **C** Syndrome mononucléosique plutôt chez l'adulte, avec angine moins marquée ; on y pense quand l'EBV est négatif.
- **D** Ganglions cervicaux indolores, peu d'angine ; contexte chat ou viande peu cuite.
- **E** Elle se présente avec cytopénies ou blastes, pas avec une lymphocytose atypique et une angine fébrile.

③ **Perle** Signe de Hoagland : œdème bilatéral indolore des paupières supérieures. Le patient n'a pas besoin d'être isolé (séroprévalence > 90 %).

④ **Source** Phase B DX.4 §8 · LOT_002 audité

Q13 **EX** DX.4 vs DX.5

✅ **C** — Demander une sérologie EBV (VCA-IgM, EBNA) ou répéter le test plus tard

① **Pourquoi c'est juste** Un test hétérophile négatif la première semaine n'exclut pas la mononucléose. La sérologie EBV est plus sensible et plus spécifique ; VCA-IgM positif avec EBNA négatif prouve la primo-infection.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le test hétérophile a des faux négatifs en 1re semaine et avant 5 ans ; sa sensibilité n'est que de 87 %.
- **B** Contre-indiquée si une mononucléose est possible (exanthème > 90 %) ; et pas de test streptocoque positif.
- **D** Le CMV se cherche quand l'EBV est négatif ; ici l'EBV n'est pas encore écarté.
- **E** Aucun drapeau rouge ; tableau aigu typique.

③ **Perle** VCA-IgG isolé = infection ancienne possible : ne suffit pas. Lymphocytose seule : ne suffit pas.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_002 audité

Q14 EX DX.5 vs DX.4

✅ **D** — Sérologie CMV (IgM et IgG) avec avidité des IgG

① **Pourquoi c'est juste** Syndrome mononucléosique avec EBV négatif → CMV (DX.5). IgM positives + IgG de faible avidité = primo-infection probable ; séroconversion sur deux sérums = preuve certaine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'EBV aigu est déjà écarté par la sérologie (EBNA positif = infection ancienne).
- **B** Syndrome mononucléosique aigu sans drapeau rouge : on termine d'abord l'enquête virale.
- **C** Une PCR faiblement positive chez l'immunocompétent ne suffit pas : excrétion prolongée sans maladie.
- **E** Angine discrète, adulte, lymphocytose atypique : le streptocoque n'explique pas le tableau.

③ **Perle** Chez l'adulte à hétérophile négatif, pensez aussi au VIH et à la toxoplasmose.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_002 audité

Q15 EX DX.5

✅ **A** — Traitement symptomatique par paracétamol, sans antiviral

① **Pourquoi c'est juste** Le médecin ne traite pas par antiviral l'immunocompétent bien portant ; le traitement est symptomatique. L'immunodéprimé fébrile, lui, est hospitalisé (ganciclovir ou valganciclovir adapté à la clairance).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Dose d'induction de la rétinite ; l'antiviral n'est pas indiqué chez l'immunocompétent bien portant.
- **C** Réservé à l'immunodéprimé ou aux formes graves, à l'hôpital.
- **D** Jamais d'amoxicilline dans un syndrome mononucléosique ; pas d'infection bactérienne.
- **E** Pas de corticoïde de routine ; et jamais avant d'avoir exclu un lymphome si le ganglion persiste.

③ **Perle** Valganciclovir : jamais pendant la grossesse ni l'allaitement (AIPS). Ganglion persistant > 4 semaines ou sus-claviculaire → biopsie, même si un CMV est prouvé.

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_002 audité

Q16 EX DX.6 vs DX.4

✅ **B** — Test de diagnostic rapide (TDR) du streptocoque, antibiotique seulement s'il est positif

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre > 38 °C, absence de toux, adénopathie cervicale antérieure douloureuse, exsudat = 4 critères de Centor ; McIsaac +1 pour l'âge 3–14 ans. Score 3–4 → TDR ; traiter seulement si positif.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un score élevé seul trie mal les patients à traiter ; on teste avec 3 à 4 critères et on traite si le test est positif.
- **C** Pas de ganglions postérieurs ni de rate ; l'âge et le score orientent vers le streptocoque.
- **D** Les ASLO montent des semaines plus tard : inutiles en phase aiguë.
- **E** Avec 4 critères de Centor (+1 McIsaac pour 3–14 ans), le test est indiqué.

③ **Perle** L'exsudat seul ne tranche pas : EBV et adénovirus donnent le même aspect. Un test positif sans symptôme peut n'être qu'un portage.

④ **Source** Phase B DX.6 §8 · LOT_002 audité

Q17 EX DX.6

✅ **D** — Culture pharyngée

① **Pourquoi c'est juste** Chez l'enfant, un TDR négatif impose une culture pharyngée (critère de référence) ; chez l'adulte, non.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Valable chez l'ADULTE (l'ESCMID n'exige pas de culture après TDR négatif) ; chez l'enfant, le TDR manque 14 malades sur 100.
- **B** On ne traite que sur un test positif.
- **C** Inutiles en phase aiguë.
- **E** Rien n'oriente vers l'EBV chez cet enfant de 7 ans.

③ **Perle** Retenez l'asymétrie enfant/adulte : c'est une question classique de l'examen fédéral.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_002 audité

Q18 EX DX.1 vs DX.8

✅ **C** — Amoxicilline-clavulanate 3 × 625 mg par jour, puis réexamen du ganglion à 3 à 4 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Adénite bactérienne d'une infection de la peau ou des tissus mous (DX.1) : Augmentin® 3 × 625 mg/j (adulte > 40 kg) couvre staphylocoque et streptocoque.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de la syphilis précoce ; elle ne couvre pas le staphylocoque d'une plaie cutanée.
- **B** Option (hors AIPS) de la maladie des griffes du chat ; ici pas de chat et une infection cutanée banale.
- **D** Jamais de corticoïde devant une adénopathie inexpliquée ; il ne traite pas l'infection.
- **E** Adénite réactionnelle avec porte d'entrée évidente : traiter et revoir.

③ **Perle** Clairance 10–30 mL/min : 625 mg toutes les 12 h. Persistance du ganglion après traitement → échographie.

④ **Source** Phase A §11.B Traitement par cause · LOT_002 audité

Q19 EX DX.2 🚩E2 vs DX.12

✅ **D** — Hémogramme et LDH, puis biopsie-exérèse du ganglion le plus anormal, sans corticoïde préalable

① **Pourquoi c'est juste** Symptômes B (fièvre, sueurs nocturnes, perte > 10 % en 6 mois) + ganglions durs dans plusieurs régions + splénomégalie = néoplasie hématologique jusqu'à preuve du contraire (DX.2, E2) : hémogramme, LDH, biopsie-exérèse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La cytoponction peut passer à côté d'un lymphome ; négative, elle n'exclut rien.
- **B** Le corticoïde lyse le lymphome et masque l'histologie.
- **C** Le TEP-TDM stadifie un lymphome confirmé ; il ne remplace pas la biopsie.
- **E** Un IGRA négatif n'exclut pas la tuberculose, mais on ne traite pas à l'aveugle : la biopsie avec culture tranche entre tuberculose et lymphome.

③ **Perle** Demandez sur la même pièce l'histologie ET la PCR/culture mycobactériennes : le même ganglion répond aux deux hypothèses graves.

④ **Source** Phase A Algorithme, étape 2 · LOT_002 audité

Q20 EX DX.3 vs DX.9

✅ **A** — Compléter par PCR et culture mycobactériennes (et fongiques) avant de retenir une sarcoïdose

① **Pourquoi c'est juste** Le granulome est un motif histologique (DX.3). Critères ATS 2020 de sarcoïdose : tableau compatible + granulome non nécrosant + exclusion des autres causes (tuberculose, mycobactéries, champignons, médicaments, cancer). Les trois sont nécessaires.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un granulome seul ne suffit pas : il faut un tableau compatible ET l'exclusion des autres granulomatoses (ATS 2020).
- **C** Un IGRA négatif n'exclut pas la tuberculose : biopsie avec culture et PCR.
- **D** Un granulome ganglionnaire décrit un motif histologique, pas une maladie : il impose de chercher la cause.
- **E** Ils orientent vers le lupus, pas vers la cause d'un granulome.

③ **Perle** Tuberculose et sarcoïdose sont les deux causes principales ; un tiers des cas reste sans diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_002 audité

Q21 EX DX.3 vs DX.12

✅ **E** — Une infection, en premier lieu la tuberculose

① **Pourquoi c'est juste** Granulome nécrosant → infection (tuberculose, mycobactérie non tuberculeuse, Bartonella, champignon) ; non nécrosant → sarcoïdose après exclusion de l'infection.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La sarcoïdose donne des granulomes NON nécrosants, après exclusion de l'infection.
- **B** Le lupus n'est pas une cause classique de granulome caséeux.
- **C** Infiltrat polymorphe sans clonalité, pas de nécrose caséeuse.
- **D** Elle conserve l'architecture, sans granulome.

③ **Perle** Granulome caséeux + PCR positive = tuberculose certaine ; granulome caséeux + tableau compatible, culture en attente = probable, on traite.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_002 audité

Q22 EX DX.7 vs DX.4

✅ **D** — Demander l'avidité des IgG anti-toxoplasme

① **Pourquoi c'est juste** IgM positives isolées ne suffisent pas : l'avidité des IgG tranche (faible = infection récente). Une adénopathie cervicale ou occipitale isolée chez un patient fébrile en bonne santé évoque la toxoplasmose (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les IgM peuvent persister des mois, voire des années : elles ne suffisent jamais.
- **B** Réservés aux formes oculaire, congénitale ou de l'immunodéprimé ; et l'infection n'est pas encore datée.
- **C** Ganglions récents, indolores, sans drapeau rouge ; on date d'abord l'infection.
- **E** Pas de papule d'inoculation ni de ganglion régional sur le trajet d'une griffure.

③ **Perle** IgG positives seules = contact ancien (un tiers des Suisses). Le dépistage systématique en grossesse est abandonné en Suisse depuis 2008.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_002 audité

Q23 EX DX.7

✅ **E** — Abstention thérapeutique et surveillance du ganglion

① **Pourquoi c'est juste** La forme ganglionnaire bénigne de l'immunocompétent guérit seule : abstention (traitement réservé aux formes sévères ou persistantes, oculaires, congénitales, immunodéprimé).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Schéma réservé aux atteintes oculaire, congénitale ou de l'immunodéprimé.
- **B** Non indiqué dans la toxoplasmose selon l'AIPS (alternative d'études seulement).
- **C** Option de la maladie des griffes du chat, pas de la toxoplasmose.
- **D** Aucune indication ; masque un lymphome si le ganglion persiste.

③ **Perle** Ganglion sus-claviculaire, dur ou persistant > 4 semaines → biopsie, même avec une sérologie toxo positive.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_002 audité

Q24 **EX** **DX.8 vs DX.7**

✅ **E** — Maladie des griffes du chat (Bartonella henselae)

① **Pourquoi c'est juste** Papule d'inoculation + adénopathie régionale subaiguë sur le trajet d'une griffure de chat = maladie des griffes du chat (DX.8) ; le diagnostic est clinique dans la forme typique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contact avec le chat aussi, mais ganglions cervicaux ou occipitaux indolores, sans papule d'inoculation sur le territoire.
- **B** Ganglion froid, souvent fistulisé, contage ; pas de papule d'inoculation.
- **C** Ganglion dur, fixe, indolore, symptômes B ; ici ganglion sensible sur le trajet d'une griffure.
- **D** Fièvre ≥ 5 jours et critères cutanéo-muqueux absents.

③ **Perle** Bartonella henselae est un bacille à Gram négatif transmis par les puces du chat. La papule manque dans de nombreux cas ; une sérologie négative précoce n'exclut pas (séroconversion tardive, PCR utile).

④ **Source** Phase B DX.8 §8 · LOT_002 audité

Q25 **EX** **DX.9 vs DX.3**

✅ **D** — Retenir un syndrome de Löfgren sur le tableau clinique, sans biopsie

① **Pourquoi c'est juste** Adénopathies hilaires bilatérales + érythème noueux ou périarthrite des chevilles + fièvre = syndrome de Löfgren (sarcoïdose, DX.9), diagnostic clinique sans biopsie si le tableau est typique.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le Löfgren typique se diagnostique cliniquement sans biopsie.
- **B** Le Löfgren guérit le plus souvent sans séquelle ; pas de corticothérapie d'emblée.
- **C** Érythème noueux + adénopathies hilaires bilatérales + périarthrite des chevilles = Löfgren, pas tuberculose.
- **E** Le tableau typique suffit ; la TEP n'est pas indiquée.

③ **Perle** Prévalence vie entière de la sarcoïdose en Suisse : 121/100 000 ; incidence 7/100 000/an. La calcémie fait partie du bilan de toute sarcoïdose suspectée.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_002 audité

Q26 EX DX.9 vs DX.11

✅ **D** — Biopsie sans attendre, après imagerie

① **Pourquoi c'est juste** Chez un lupique, un ganglion sus-claviculaire dur se biopsie sans attendre : il évoque un cancer ou un lymphome. Le terrain auto-immun ne protège pas de la néoplasie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une adénopathie ne se range jamais dans une maladie auto-immune sans exclure lymphome et tuberculose ; le corticoïde masquerait un lymphome.
- **B** Le siège sus-claviculaire n'autorise aucune observation.
- **C** Il n'explique pas un ganglion sus-claviculaire dur.
- **E** Le ganglion dur sus-claviculaire évoque un cancer ou un lymphome, pas l'activité lupique.

③ **Perle** Même réflexe sous méthotrexate : un nouveau ganglion impose l'arrêt du produit, un avis spécialisé et une biopsie.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_002 audité

Q27 EX DX.10

✅ **B** — Arrêter la phénytoïne immédiatement et organiser un relais antiépileptique avec le neurologue

① **Pourquoi c'est juste** Le traitement de l'adénopathie médicamenteuse est l'arrêt du médicament en cause ; pour un antiépileptique, l'arrêt brusque sans relais expose à un état de mal, d'où le relais organisé avec le neurologue.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Fièvre et éruption sous phénytoïne imposent l'arrêt immédiat (AIPS).
- **C** Réaction croisée connue entre antiépileptiques aromatiques.
- **D** L'arrêt du médicament est urgent ; la biopsie ne se discute que si l'adénopathie persiste après l'arrêt.
- **E** Une hypersensibilité n'est pas dose-dépendante : arrêt.

③ **Perle** Après une réaction cutanée grave à la phénytoïne : jamais de réintroduction, jamais de test de réintroduction.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_002 audité

Q28 EX DX.10 vs DX.2

✅ **D** — Biopsie-exérèse du ganglion

① **Pourquoi c'est juste** Le pseudolymphome médicamenteux régresse à l'arrêt du médicament ; s'il persiste, un lymphome vrai est possible : biopsie excisionnelle (infiltrat polymorphe sans clonalité = compatible, mais il faut exclure la clonalité).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le pseudolymphome RÉGRESSE à l'arrêt ; un lymphome vrai persiste.
- **B** Interdit : l'AIPS exclut toute reprise après une réaction cutanée grave.
- **C** Le corticoïde masquerait un lymphome.
- **E** Persistance > 4–6 semaines : on prélève, on n'attend plus.

③ **Perle** Diagnostic de pseudolymphome = rétrospectif : adénopathie après introduction + régression à l'arrêt.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_002 audité

Q29 EX DX.11 🚩E3

✅ **E** — Biopsie chirurgicale d'exérèse du ganglion

① **Pourquoi c'est juste** Une ponction non diagnostique d'un ganglion sus-claviculaire impose une biopsie chirurgicale d'exérèse : l'image ne donne pas l'histologie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une ponction non diagnostique n'exclut rien : 50 ponctions sur 270 étaient non diagnostiques dans la série lue.
- **B** Il retarde le diagnostic ; ce siège n'est presque jamais réactif.
- **C** Le TEP vient si le primitif reste inconnu ; il ne donne pas l'histologie.
- **D** Elle peut effacer l'image histologique d'un lymphome.

③ **Perle** La tuberculose ganglionnaire imite la métastase sus-claviculaire : 25,9 % des cytologies de la série étaient granulomateuses. D'où PCR/culture sur la pièce.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_002 audité

Q30 EX DX.12

✅ **C** — 6 mois : 2 mois de rifampicine-isoniazide-pyrazinamide-éthambutol, puis 4 mois de rifampicine-isoniazide

① **Pourquoi c'est juste** Standard : 6 mois, 2 HRZE + 4 HR. La forme ganglionnaire isolée n'est pas contagieuse (pas d'isolement), mais elle se déclare à l'OFSP.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La phase intensive de 2 mois est suivie de 4 mois de bithérapie.
- **B** Schéma de la prophylaxie de l'infection latente, pas de la maladie.
- **D** La chirurgie ne remplace pas le traitement de la maladie active.
- **E** Pas de standard sans phase intensive ; la durée prolongée concerne les formes disséminées ou neuroméningées.

③ **Perle** Surveiller ASAT/ALAT toutes les 2 à 4 semaines, l'acuité et la vision rouge-vert sous éthambutol, ajouter la pyridoxine sous isoniazide.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_002 audité

Q31 EX DX.13 🚩E5 vs DX.4

✅ **B** — Test VIH combiné de 4e génération, complété par l'ARN du VIH (charge virale)

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre + pharyngite + éruption + adénopathies après exposition = primo-infection VIH jusqu'à preuve du contraire (DX.13, E5). Le test combiné (anticorps + p24) et l'ARN posent le diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'EBV ressemble à la primo-infection VIH, mais l'exposition impose le test VIH ; on teste les quatre (VIH, EBV, CMV, syphilis).
- **C** Un test rapide ou un autotest négatif ne suffit pas, surtout en phase aiguë.
- **D** Tableau aigu post-exposition : le diagnostic est biologique.
- **E** La fenêtre sérologique se contourne par l'antigène p24 et l'ARN ; attendre 3 mois retarde le traitement.

③ **Perle** Dépister aussi la syphilis et les autres IST chez tout nouveau cas de VIH.

④ **Source** Phase B DX.13 §8 · LOT_002 audité

Q32 EX DX.13

✅ **A** — Le jour même du diagnostic, sans attendre le génotype

① **Pourquoi c'est juste** Le traitement antirétroviral commence le jour du diagnostic, sans attendre le génotype (EACS 2025), initié par un médecin expérimenté (infectiologue).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le génotype ajuste le traitement ensuite ; il ne le retarde pas.
- **C** Ancienne stratégie : on traite tout diagnostic d'emblée.
- **D** Le traitement n'attend pas la séroconversion.
- **E** Aucune base ; le traitement précoce est la règle.

③ **Perle** But : charge virale indétectable.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_002 audité

Q33 EX DX.14 🚩E6 vs DX.13

✅ **E** — Un test tréponémique et un test non tréponémique avec titre

① **Pourquoi c'est juste** Éruption palmo-plantaire non prurigineuse + adénopathies généralisées = syphilis secondaire (DX.14, E6). Diagnostic : test tréponémique + test non tréponémique actif (quantitatif).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il reste positif à vie : il ne juge pas l'activité.
- **B** Faux positifs possibles (grossesse, lupus, mononucléose).
- **C** Le diagnostic est sérologique ; la PCR ou le fond noir servent sur une lésion accessible.
- **D** Indispensable aussi, mais l'éruption palmo-plantaire oriente vers la syphilis secondaire, qui se prouve par les sérologies.

③ **Perle** Ganglion épitrochléen > 0,5 cm = pathologique (syphilis, lymphome, infection de la main). Test non tréponémique négatif avec éruption typique : phénomène de zone, diluer le sérum.

④ **Source** Phase B DX.14 §8 · LOT_002 audité

Q34 EX DX.14

✅ **E** — Benzathine benzylpénicilline (Extencilline®) 2,4 MUI IM en dose unique, et traitement des partenaires récents

① **Pourquoi c'est juste** Syphilis précoce (primaire, secondaire) : Extencilline® 2,4 MUI IM en dose unique (AIPS). Traiter les partenaires, déclarer à l'OFSP.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose de l'infection streptococcique de l'adulte, insuffisante pour la syphilis.
- **B** Schéma de la syphilis TARDIVE.
- **C** Pas de schéma de la syphilis.
- **D** Réservée à la neurosyphilis (atteint le LCR) ; pas nécessaire ici.

③ **Perle** Prévenir le patient de la réaction de Jarisch-Herxheimer (fièvre dans les 2 à 12 h).

④ **Source** Phase B DX.14 §13 · LOT_002 audité

Q35 EX DX.15 🚩E1

✅ **D** — Immunoglobulines IV 2 g/kg en dose unique avec acide acétylsalicylique, sans attendre l'échocardiographie

① **Pourquoi c'est juste** Kawasaki : immunoglobulines 2,0 g/kg en dose unique (ou 1,6–2,0 g/kg sur 2 à 5 jours) avec aspirine, avant le 10e jour de fièvre ; l'échocardiographie avec Z-score se fait sans retarder le traitement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une échographie normale au début n'exclut pas la maladie ; on traite avant le 10e jour sans la retarder.
- **B** Les corticoïdes s'ajoutent en cas de résistance aux immunoglobulines, pas seuls en première intention.
- **C** Le tableau remplit les critères ; l'antibiotique ne protège pas les coronaires.
- **E** Il ne remplace pas les immunoglobulines qui réduisent le risque coronarien.

③ **Perle** Non traité, l'anévrisme touche ≈ 25 % des cas. Échographie au diagnostic, à 1–2 semaines et à 4–6 semaines.

④ **Source** Phase B DX.15 §13 · LOT_002 audité

Q36 **AP** **DX.3 · enfant**

✅ **E** — Une mycobactérie non tuberculeuse

① **Pourquoi c'est juste** Chez l'enfant, la mycobactérie non tuberculeuse est la première cause d'adénopathie granulomateuse (50 % dans la série danoise lue).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Possible, mais chez l'enfant la première cause de granulome ganglionnaire est la mycobactérie non tuberculeuse (≈ 50 % dans la série danoise).
- **B** Granulome non nécrosant, rare à cet âge.
- **C** Hyperplasie folliculaire avec histiocytes épithélioïdes, pas de nécrose.
- **D** Pas une cause granulomateuse classique.

③ **Perle** Le granulome nécrosant oriente vers l'infection ; PCR et culture restent indispensables pour typer la mycobactérie.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_002 audité

Q37 **AP** **DX.5 · sérologie**

✅ **C** — L'avidité des IgG anti-CMV

① **Pourquoi c'est juste** Avidité = force de liaison des IgG au virus : faible dans les 2 à 4 mois suivant l'infection, puis forte. IgM + IgG de faible avidité = primo-infection probable.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les IgM persistent plusieurs mois et réagissent de façon croisée avec l'EBV.
- **B** Faux positifs décrits avec le CMV aigu ; il ne date pas le CMV.
- **D** Une excrétion prolongée existe sans maladie chez l'immunocompétent.
- **E** Signe de complication, pas outil de datation.

③ **Perle** La séroconversion sur deux sérums espacés de 2 à 3 semaines reste la seule preuve certaine.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_002 audité

Q38 **AP** **DX.6 · allergie**

✅ **B** — Clindamycine 300 mg 2 fois par jour pendant 10 jours

① **Pourquoi c'est juste** Allergie de type 1 (immédiate) : clindamycine 300 mg 2×/j pendant 10 jours (AIPS), ou un macrolide. Allergie non immédiate : céfuroxime.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Réservée à l'allergie NON immédiate ; l'œdème de Quincke est une allergie de type 1.
- **C** Pénicilline : contre-indiquée.
- **D** Pénicilline : contre-indiquée.
- **E** Céphalosporine réservée à l'abcès ; même problème que la céfuroxime dans l'allergie immédiate.

③ **Perle** Durée : 10 jours pour les streptocoques bêta-hémolytiques. Le traitement de référence reste la pénicilline V.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_002 audité

Q39 **AP** **DX.7 · pharmacologie**

✅ **A** — La pyriméthamine inhibe la dihydrofolate réductase : seul un folate déjà réduit (folinate) contourne le blocage

① **Pourquoi c'est juste** La pyriméthamine bloque la DHFR ; l'acide folique pur doit être réduit par cette enzyme et ne corrige donc pas le déficit. Le folinate (déjà réduit) protège la moelle.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Ce n'est pas le mécanisme invoqué dans le cours.
- **C** Faux : le problème est pharmacologique (DHFR), pas le terrain.
- **D** Il protège la moelle du patient, il n'est pas antiparasitaire.
- **E** Aucune interaction de ce type n'est décrite.

③ **Perle** Hémogramme chaque semaine (2×/sem chez l'immunosupprimé) ; pyriméthamine exclue au 1er trimestre de grossesse.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_002 audité

Q40 **AP** **DX.10 · réaction croisée**

✅ **A** — Carbamazépine

① **Pourquoi c'est juste** Réaction croisée entre antiépileptiques aromatiques (phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital) : on ne remplace pas la phénytoïne par la carbamazépine.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Non aromatique : pas de réaction croisée décrite dans le cours.
- **C** Non aromatique : pas de réaction croisée décrite dans le cours.
- **D** Benzodiazépine non aromatique, pas de réaction croisée décrite.
- **E** Non cité parmi les aromatiques à réaction croisée.

③ **Perle** L'arrêt brusque d'un antiépileptique expose à un état de mal : relais organisé.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_002 audité

Q41 **AP** **DX.12 · réaction paradoxale**

✅ **B** — Une réaction paradoxale : on poursuit le traitement et on demande un avis

① **Pourquoi c'est juste** Une aggravation du ganglion sous traitement évoque une réaction paradoxale, pas un échec : on poursuit et on demande un avis.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sur souche sensible, avec observance et culture négative, l'aggravation évoque d'abord une réaction paradoxale.
- **C** On n'arrête pas un traitement efficace ; l'avis spécialisé décide d'un éventuel prélèvement.
- **D** L'éthambutol donne une névrite optique, pas un ganglion.
- **E** L'incision d'un abcès froid crée une fistule chronique.

③ **Perle** Sous rifampicine : contraception non hormonale. Sous isoniazide : pyridoxine 10–20 mg/j.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_002 audité

Q42 **AP** **DX.13 · U=U**

✅ **B** — Non : avec un ARN durablement indétectable, le VIH ne se transmet pas par voie sexuelle (U=U)

① **Pourquoi c'est juste** U=U (Undetectable = Untransmittable) : un patient traité avec un ARN indétectable ne transmet pas le virus par voie sexuelle.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Faux : principe U=U.
- **C** La PEP traite une exposition ponctuelle, ce n'est pas une stratégie de couple.
- **D** C'est la charge virale indétectable qui fonde U=U.
- **E** Les anticorps persistent ; ils ne déterminent pas la transmission.

③ **Perle** Le but du traitement est la charge virale indétectable — bénéfice individuel ET de santé publique.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_002 audité

Q43 **AP** **DX.14 · Jarisch-Herxheimer**

✅ **A** — Réaction de Jarisch-Herxheimer : rassurer et donner un antipyrétique

① **Pourquoi c'est juste** Jarisch-Herxheimer : fièvre dans les 2 à 12 heures après la première injection ; rassurer et donner un antipyrétique. Il faut en prévenir le patient avant l'injection.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Délai de 2 à 12 h, fièvre et majoration de l'éruption sans signe anaphylactique : réaction attendue, pas une allergie.
- **C** La réaction témoigne de la lyse des tréponèmes, pas d'un échec.
- **D** Aucun signe neurologique ; la réaction est systémique et transitoire.
- **E** Le test VIH est utile, mais n'explique pas la fièvre post-injection.

③ **Perle** Toujours associer le test VIH et le traitement des partenaires récents.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_002 audité

Q44 **AP** **DX.15 · résistance IVIG**

✅ **B** — Retenir une résistance aux immunoglobulines : ajouter un corticoïde ou une deuxième cure

① **Pourquoi c'est juste** Une fièvre persistante ou récurrente ≥ 36 heures après la fin des immunoglobulines signe une résistance : corticoïde ou deuxième cure.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Fièvre ≥ 36 h après la fin de la perfusion = résistance ; l'attente expose les coronaires.
- **C** L'ibuprofène est évité sous aspirine : il peut inhiber l'effet antiagrégant.
- **D** Aucun argument infectieux ; il s'agit de la maladie.
- **E** Elle reste indiquée.

③ **Perle** Le score de Kobayashi (risque de résistance) est peu fiable chez l'enfant européen : ne pas s'y fier en Suisse.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_002 audité

Q45 **SPE · Hématologie** **DX.2 · Lugano**

✅ **B** — Stade III

① **Pourquoi c'est juste** Lugano 2014 : I = une aire ; II = ≥ 2 aires du même côté du diaphragme ; III = des deux côtés ; IV = extra-ganglionnaire non contigu. Le PET-TDM est intégré à la stadification des lymphomes avides de FDG.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une seule aire ganglionnaire.
- **C** Deux aires ou plus du MÊME côté du diaphragme ; ici les deux côtés sont atteints.
- **D** Exige une atteinte extra-ganglionnaire non contiguë.
- **E** La biopsie médullaire n'est plus indiquée en routine pour le Hodgkin ; le PET-TDM stadifie.

③ **Perle** Suffixes A/B réservés au Hodgkin. Ne jamais associer bléomycine et brentuximab (toxicité pulmonaire).

④ **Source** Phase B DX.2 §8 · LOT_002 audité

Q46 **SPE · Pneumologie** **DX.3 · sarcoïdose**

✅ **C** — La calcémie

① **Pourquoi c'est juste** La calcémie et l'ECG font partie du bilan de toute sarcoïdose suspectée ; la calcémie a une recommandation forte.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'ECA aide mais ne pose pas le diagnostic ; la recommandation forte vise la calcémie.
- **B** Non systématique dans le bilan de base.
- **D** Sans objet dans la sarcoïdose.
- **E** L'IGRA ne surveille pas une sarcoïdose.

③ **Perle** Sous immunothérapie anticancéreuse, un granulome peut être une réaction sarcoïdosique et non une progression : biopsier.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_002 audité

Q47 **SPE · Infectiologie** **DX.7 · encéphalite**

✅ **A** — Pyriméthamine + clindamycine + acide folinique, sans attendre la PCR

① **Pourquoi c'est juste** Encéphalite toxoplasmique de l'immunodéprimé : diagnostic de probabilité (image annulaire, IgG +, réponse au traitement) ; en cas d'allergie aux sulfamides, clindamycine + pyriméthamine pendant 8 à 10 semaines, avec folinate.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Contre-indiqué par l'allergie aux sulfamides.
- **C** Chez l'immunodéprimé avec lésions cérébrales, on traite l'encéphalite sans attendre la PCR.
- **D** Elle s'associe toujours à un sulfamide ou à la clindamycine, avec folinate.
- **E** Non indiqué dans la toxoplasmose selon l'AIPS.

③ **Perle** Hémogramme deux fois par semaine chez l'immunosupprimé sous pyriméthamine.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_002 audité

Q48 **SPE · Ophtalmologie** **DX.8 · œil**

✅ **C** — Neurorétinite à Bartonella henselae

① **Pourquoi c'est juste** Atteinte oculaire typique de la maladie des griffes du chat : neurorétinite avec œdème papillaire et étoile maculaire ; le syndrome oculoglandulaire de Parinaud en est une autre forme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Lésion focale nécrosante, pas d'étoile maculaire avec œdème papillaire.
- **B** Œdème papillaire bilatéral, sans étoile maculaire, sans contexte de griffure.
- **D** Terrain d'immunodépression.
- **E** Atteinte cutanée et articulaire, pas de neurorétinite.

③ **Perle** Baisse de vision, souffle cardiaque ou immunodépression fébrile = avis spécialisé le jour même.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_002 audité

Q49 **SPE · Rhumatologie** **DX.9 · méthotrexate**

✅ **D** — Arrêter le méthotrexate, demander un avis spécialisé et biopsier le ganglion

① **Pourquoi c'est juste** Sous méthotrexate, un nouveau ganglion impose l'arrêt du produit, un avis spécialisé et une biopsie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un nouveau ganglion sous méthotrexate impose l'arrêt, un avis et une biopsie.
- **B** Jamais quotidien : une seule prise par semaine ; le surdosage est grave.
- **C** Masquerait un lymphome.
- **E** Ganglion nouveau, ferme, indolore sous immunosuppresseur : pas d'attente.

③ **Perle** Méthotrexate : une fois par semaine ; contre-indiqué pendant la grossesse ; contraception ≥ 6 mois après l'arrêt chez la femme, ≥ 3 mois chez l'homme.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_002 audité

Q50 **SPE · Neurologie** **DX.10 · pharmacogénétique**

✅ **C** — HLA-B*1502

① **Pourquoi c'est juste** L'AIPS de la phénytoïne cite HLA-B*1502 comme facteur de risque de SSJ chez les sujets chinois Han.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Associé au syndrome d'hypersensibilité à l'allopurinol.
- **B** Spondylarthropathies, sans lien avec la phénytoïne.
- **D** Polyarthrite rhumatoïde, sans lien avec la phénytoïne.
- **E** Non cité dans le cours pour la phénytoïne.

③ **Perle** Taux plasmatique thérapeutique de la phénytoïne : 10 à 20 µg/mL (AIPS).

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_002 audité

Q51 **SPE · Pneumologie** **DX.12 · rifampicine**

✅ **C** — Passer à une contraception non hormonale pendant le traitement par rifampicine

① **Pourquoi c'est juste** La rifampicine rend les contraceptifs hormonaux inefficaces : contraception non hormonale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La rifampicine rend les contraceptifs hormonaux inefficaces.
- **B** Non recommandé ; la contraception doit être non hormonale.
- **D** On ne sacrifie pas le pilier du traitement.
- **E** L'éthambutol ne s'emploie jamais en monothérapie.

③ **Perle** Hépatotoxicité : arrêt envisagé si transaminases > 100 U/L avec bilirubine élevée ; sous isoniazide, arrêt au-delà de 3 fois la normale ; avis spécialisé.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_002 audité

Q52 **SPE · Infectiologie** **DX.13 · Fiebig**

✅ **A** — Stade I

① **Pourquoi c'est juste** Fiebig I : seul l'ARN est détectable ; II : p24 ; III : anticorps à l'immunoessai ; IV : Western blot indéterminé ; V : positif sauf p31 ; VI : complet.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'antigène p24 est apparu.
- **C** Les anticorps de l'immunoessai sont apparus.
- **D** Western blot positif sauf p31.
- **E** Western blot complet.

③ **Perle** ARN détectable avec anticorps négatifs = phase aiguë probable : confirmer par séroconversion ou 2e prélèvement ; une faible charge virale isolée peut être un faux positif.

④ **Source** Phase B DX.13 §8 · LOT_002 audité

Q53 **SPE · Dermato-vénéréologie** **DX.14 · neurosyphilis**

✅ **D** — Pénicilline G intraveineuse

① **Pourquoi c'est juste** La neurosyphilis exige la pénicilline G intraveineuse, qui atteint le LCR ; d'où la recherche d'une atteinte neurologique, oculaire ou otique AVANT de traiter une syphilis secondaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS exclut la neurosyphilis : la benzathine n'atteint pas le LCR.
- **B** Schéma de la syphilis tardive, pas de la neurosyphilis.
- **C** Alternative de la syphilis précoce chez l'allergique non enceinte.
- **E** Aucun schéma de la syphilis dans le cours.

③ **Perle** Femme enceinte : toujours la pénicilline ; la doxycycline est réservée à l'allergique non enceinte.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_002 audité

Q54 SPE · Cardiologie pédiatrique DX.15 · coronaires

✅ **B** — Aspirine associée à une anticoagulation (phenprocoumone INR 2,0–3,0 ou énoxaparine)

① **Pourquoi c'est juste** Anévrisme géant = Z-score ≥ 10 ou diamètre ≥ 8 mm (AHA 2017) : aspirine + anticoagulation, suivi rapproché.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Conduite de l'absence d'atteinte ou de la dilatation seule (Z < 2,5).
- **C** Conduite du petit anévrisme (Z 2,5 à < 5).
- **D** Conduite de l'anévrisme moyen (Z 5 à < 10, < 8 mm).
- **E** L'anévrisme géant impose anticoagulation et suivi rapproché.

③ **Perle** Après immunoglobulines : vaccins vivants reportés (AIPS 3 mois, jusqu'à 1 an pour la rougeole) ; aspirine + varicelle ou grippe = risque de syndrome de Reye.

④ **Source** Phase B DX.15 §8 · LOT_002 audité

Q55 EX DX.2 🚩 corticoïde

✅ **E** — Refuser tout corticoïde avant la biopsie, car il peut masquer un lymphome

① **Pourquoi c'est juste** Point clé : ne jamais donner de corticoïde avant d'avoir exclu un lymphome. Un ganglion > 1 cm persistant au-delà de 4 à 6 semaines impose la biopsie-exérèse.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le corticoïde lyse le lymphome et masque l'histologie.
- **B** Ganglion > 6 semaines = biopsie ; et jamais de corticoïde avant.
- **C** Même piège : altération histologique.
- **D** Même une dose peut fausser l'histologie d'un lymphome.

③ **Perle** Le corticoïde favorise aussi la tuberculose en cas de granulome méconnu.

④ **Source** Phase A §13 Points clés · LOT_002 audité

Q56 EX DX.2 🚩 cytopénie

✅ **C** — Avis hématologique le jour même

① **Pourquoi c'est juste** Cytopénie ou blastes à l'hémogramme = infiltration médullaire (DX.2, leucémie) : frottis et avis hématologique le jour même.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les cytopénies avec blastes signent une infiltration médullaire, pas une mononucléose.
- **B** Le frottis oriente déjà vers une leucémie : l'urgence est hématologique.
- **D** L'anémie est ici centrale, pas carentielle.
- **E** Ne change rien à l'urgence.

③ **Perle** Chaque drapeau rouge a son action : blastes → hématologue aujourd'hui.

④ **Source** Phase A §4 Drapeaux rouges · LOT_002 audité

Q57 EX DX.4

✅ **E** — Pas de sport de contact pendant au moins 3 semaines, parfois jusqu'à disparition de la splénomégalie

① **Pourquoi c'est juste** Rupture splénique : 0,1 à 0,5 %, le plus souvent dans les 3 semaines. Pas de sport de contact avant 3 semaines, parfois jusqu'à 8 semaines ou disparition de la splénomégalie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le risque de rupture splénique persiste surtout dans les 3 premières semaines, indépendamment de la fièvre.
- **B** Aucune protection ne remplace l'éviction.
- **C** Pas de corticoïde de routine ; aucun effet démontré sur le risque splénique.
- **D** Le test ne guide pas la reprise.

③ **Perle** Douleur de l'hypocondre ou de l'épaule gauche = exclure une rupture splénique en urgence.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_002 audité

Q58 EX DX.4 vs DX.6

✅ **D** — Amoxicilline

① **Pourquoi c'est juste** L'amoxicilline est contre-indiquée dans la mononucléose (AIPS) : exanthème dans plus de 90 % des cas.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement symptomatique de référence (max 4 g/j chez l'adulte).
- **B** Antalgique accepté pour la gorge dans le cours.
- **C** Mesure de soutien sans contre-indication.
- **E** Antalgique local sans contre-indication liée à la mononucléose.

③ **Perle** Cet exanthème est le plus souvent non allergique : ne pas étiqueter « allergie à la pénicilline » sans confirmation.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_002 audité

Q59 EX DX.8

✅ **B** — Aspiration à l'aiguille pour soulager la douleur

① **Pourquoi c'est juste** Ganglion fluctuant de la maladie des griffes du chat : aspiration à l'aiguille, pas d'incision. L'antibiotique est facultatif chez l'immunocompétent.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On n'incise pas : risque de fistule chronique ; on aspire.
- **C** Maladie spontanément résolutive ; l'exérèse n'est pas le geste de la forme typique fluctuante.
- **D** Réservée à l'endocardite à Bartonella (avec doxycycline).
- **E** Aucune indication.

③ **Perle** Azithromycine (hors AIPS) : réduction plus rapide du volume du ganglion le 1er mois (7/14 contre 1/15), sans différence ensuite.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_002 audité

Q60 EX DX.12 🚩E4

✅ **A** — Poursuivre : PCR et culture mycobactériennes sur le prélèvement

① **Pourquoi c'est juste** Un IGRA négatif avec ganglion caséeux ne dispense pas de la PCR et de la culture : seule la preuve du bacille (ou le faisceau granulome caséeux + tableau) pose le diagnostic.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sensibilité groupée de l'IGRA ≈ 0,89 : environ un cas sur dix passe à travers.
- **C** Le granulome caséeux oriente vers l'infection, pas la sarcoïdose.
- **D** L'IGRA ne prouve ni n'exclut la maladie ganglionnaire ; la preuve est sur le ganglion.
- **E** Le corticoïde favorise la tuberculose et masque un lymphome.

③ **Perle** Les trois quarts des tuberculoses suisses sont d'origine étrangère ; l'Xpert sur ganglion n'est pas parfait non plus (sensibilité ≈ 79 %).

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_002 audité

Q61 EX DX.12

✅ **E** — Pyrazinamide

① **Pourquoi c'est juste** Le pyrazinamide ne doit pas être pris pendant la grossesse ni l'allaitement (AIPS) ; il est aussi contre-indiqué en cas d'hépatite aiguë ou de clairance < 50 mL/min.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas d'interdiction de grossesse citée dans le cours ; interaction avec les contraceptifs hormonaux.
- **B** Pas d'interdiction de grossesse citée ; associer la pyridoxine.
- **C** Pas d'interdiction de grossesse citée ; surveiller la vision.
- **D** Supplément vitaminique associé à l'isoniazide, sans interdiction.

③ **Perle** Point clé de la monographie G2 : « Le pyrazinamide est interdit pendant la grossesse selon l'AIPS. »

④ **Source** Phase A §11.B Situations spéciales · LOT_002 audité

Q62 **EX** DX.13 🚩E5

✅ **A** — Doser l'ARN du VIH et répéter le test combiné à 2–4 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Un test combiné négatif à J10 n'exclut pas le VIH : l'ARN (stade de Fiebig I) et la répétition du test tranchent.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Fenêtre sérologique : un test négatif tôt après l'exposition n'exclut pas la primo-infection.
- **C** Chez un patient fébrile exposé récemment, la PrEP se retarde et le statut VIH se reconfirme : la PrEP seule sur une infection aiguë sélectionne des résistances.
- **D** La PEP se démarre si l'exposition date de moins de 72 heures ; ici 10 jours.
- **E** On teste les quatre (VIH, EBV, CMV, syphilis) ; l'EBV ne dispense pas du VIH.

③ **Perle** Exposition < 72 h → PEP aussitôt ; au-delà, avec symptômes → ARN.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_002 audité

Q63 **EX** DX.15 🚩E1 · forme incomplète

✅ **A** — Échocardiographie et algorithme de forme incomplète de Kawasaki

① **Pourquoi c'est juste** Nourrisson < 6 mois, fièvre ≥ 7 jours, CRP élevée, sans autre cause : échocardiographie même sans critère complet ; traiter si positive.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le nourrisson fait souvent des formes incomplètes : fièvre de 7 jours sans autre cause suffit à y penser.
- **C** Les immunoglobulines se donnent avant le 10e jour ; attendre expose les coronaires.
- **D** Bilan infectieux négatif ; elle ne protège pas les coronaires.
- **E** Aucun rôle dans le Kawasaki.

③ **Perle** Forme incomplète = piège n°1 du Kawasaki chez le nourrisson.

④ **Source** Phase B DX.15 §13 · LOT_002 audité